



Le rôle des biomarqueurs biochimiques du stress professionnel chronique chez les personnels soignants : état des connaissances

**S. ALOUANI (1), S. BENAICHA (2), S. ABBASSENE (1),
M. HAMADOUCHE (1).**

(1) Université Ferhat Abbas Sétif 1
(2) Université Mostafa Benboulaïd Batna 2

Résumé:

Introduction Le stress chronique au travail touche particulièrement les soignants. Des biomarqueurs objectifs pourraient améliorer l'évaluation de la souffrance professionnelle et la décision d'aptitude médicale.

Objectifs :

- Identifier les biomarqueurs biochimiques les plus pertinents pour la détection précoce du stress professionnel chronique chez les personnels soignants.
- Proposer leur intégration dans l'évaluation de la vulnérabilité individuelle lors de la décision d'aptitude médicale au travail.

Conclusion: L'intégration de biomarqueurs biochimiques ciblés permettrait une détection précoce et objective du burn-out chez les soignants, tout en contribuant à l'évaluation de leur vulnérabilité individuelle et à la décision d'aptitude médicale.

Introduction:

Le stress professionnel chronique représente un enjeu majeur de santé publique, particulièrement chez les personnels soignants exposés aux risques psychosociaux. Leur évaluation repose actuellement sur des outils subjectifs insuffisants pour objectiver la souffrance au travail et orienter la décision d'aptitude médicale. L'identification de biomarqueurs biochimiques objectifs constitue une avancée nécessaire pour une médecine du travail plus préventive.



Résultats:

Quatre axes biologiques se distinguent :

L'axe neuroendocrinien : cortisol salivaire et ratio cortisol/DHEA-S (Sulfate de Déhydroépiandrostérone) qui constitue le reflet le plus direct de l'activation chronique de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien.

L'axe métabolique : glycémie, HbA1c et bilan lipidique qui traduit les perturbations induites par l'hypercortisolémie prolongée.

L'axe inflammatoire : CRP ultrasensible, IL-6 et TNF- α qui reflète l'inflammation systémique de bas grade caractéristique du burn-out sévère.

L'axe oxydatif : malondialdéhyde et superoxyde dismutase qui témoignent des dommages cellulaires liés au stress chronique.

L'association cortisol salivaire + CRP ultrasensible + ratio cortisol/DHEA-S présente la meilleure valeur prédictive pour identifier précocement les soignants en épuisement professionnel.

Discussion:

Les données de la littérature suggèrent que le stress professionnel chronique et le burn-out s'accompagnent de **modifications biologiques touchant plusieurs axes physiologiques**, notamment neuroendocrinien, métabolique, inflammatoire et oxydatif. Le cortisol salivaire, le ratio cortisol/DHEA-S et certains marqueurs inflammatoires semblent particulièrement intéressants pour objectiver précocement les effets du stress chronique. Cependant, **aucun biomarqueur isolé ne permet à lui seul de caractériser le burn-out**. L'approche combinée, notamment l'association du cortisol salivaire, de la CRP ultrasensible et du ratio cortisol/DHEA-S, pourrait apporter une information complémentaire aux outils cliniques et psychosociaux existants.



Méthode:

Il s'agit d'une revue de la littérature portant sur les biomarqueurs biochimiques du stress professionnel et du burn-out chez les personnels de santé.

Conclusion:

L'intégration d'un panel biochimique ciblé dans la surveillance médicale des soignants exposés aux risques psychosociaux permettrait une détection précoce objective du burn-out. Ces biomarqueurs pourraient aider à évaluer la vulnérabilité individuelle dans les outils d'aide à la décision d'aptitude médicale, conformément à l'Instruction Ministérielle N°18 du 27 octobre 2002.